

Komorbidności monotropowe: weryfikacja ram czterech klastrów

Cytowany przegląd badawczy — sprawdzający szeroko dzielone ramy „monotropowych komorbidności”.

Informacyjne, nie porada medyczna. Monotropizm to styl poznawczy, nie diagnoza; nie ma „komorbidności” w sensie choroby. Ten przegląd ocenia, czym nakładania się z ramami poniżej są i nie są poparte. Uzupełnia pełniejszy przegląd krajobrazowy projektu, „Monotropizm i jego sieć komorbidności”.

Podsumowanie

- **Otwarcie ram jest dokładnie słuszne: monotropizm nie ma „komorbidności” w sensie choroby.** Jest to styl uwagi na spektrum; nakładania się z warunkami klinicznymi to *asocjacje i współdzielone mechanizmy*, nie następstwa choroby [1].
- **Jedno twierdzenie wiodące jest odwrotne.** „Ludzie AuDHD osiągają najwyższe wyniki MQ ze wszystkich grup” **nie** jest tym, co pokazują dane. W studium walidacyjnym MQ, autyzm i ADHD każdy podnoszą wyniki monotropizmu, ale ich *połączony* efekt to **negatywna interakcja** ($\beta = -0,43$, $p < ,001$): autystyczni-z-ADHD osiągają **niższe wyniki, niż przewidywałby model czysto addytywny**, nie wyższe [2].
- **Dwa terminy są poprawnie przypisane, ale potrzebują precyzyjnych definicji.** „*Monotropic split*” (*rozszczenie monotropowe*) **JEST** rzeczywiście ukute przez autystyczną adwokat **Tanya Adkin** — ale oznacza kognitywny koszt *zmuszania*

monotropowego umysłu do operowania polytropowo (dzielenia uwagi), **nie** „AuDHD konkurujące tunele”, z czym czasem jest mylone [3].

- **„Problemy z trwałością obiektu” są sporne, nie ugruntowane.**
Jedynym źródłem akademickim (Lawson & Dombroski, 2017) proponuje **opóźnioną** trwałość obiektu jako *hipotezę* pewnego stresu związanego z autyzmem — a szersza literatura znajduje, że trwałość obiektu jest typowo *nienaruszona lub lepsza* w autyzmie.
Doświadczenie „poza wzrokiem, poza myślami” lepiej czyta się jako efekt **pamięci operacyjnej / alokacji uwagi** [4].
- **Reszta jest ogólnie poparta, ale gradowana przez ewidencję.**
Autyzm (fundacyjny), ADHD hyperfocus (realny), nakładanie lęk/ruminacja i OCD (robustne), autystyczna bezwładność (realna), sensoryczne przytłoczenie → meltdown/shutdown (realne) oraz burnout z wymuszonych przejść + maskowania (ugruntowany konstrukt) — wszystkie przetrwają kontrolę — z hyper-systematyzowaniem będąc **osobną teorią E-S Baron-Cohena**, nie wynikiem monotropizmu [5].
- **Neuroafirmujące reframe'owanie:** każde nakładanie lepiej wyraża się jako „*jak wąski, intensywny system uwagi interaguje z polytropowym światem*” raczej niż jako lista zaburzeń, które „powoduje” monotropowy mózg.

1. Zasada podstawowa (ramy mają to rację)

Monotropizm (Murray, Lawson & Lesser, 2005) mówi, że umysły różnią się w *tych, jak alokują uwagę*: monotropowy umysł koncentruje zasoby w kilka intensywnie aktywnych „tuneli uwagi”; polytropowy rozkłada je na wiele [1]. Ponieważ jest **wymiarowym stylem poznawczym** — mierzalnym na Monotropism Questionnaire (MQ) na skali 1–5 — nie „ma komorbidności”. Co *ma*, to **asocjacje statystyczne** (grupy, które oceniają wyżej) i **współdzielone mechanizmy** (warunki, których cechy lens alokacji uwagi pomaga wyjaśnić). Utrzymanie tego rozróżnienia to cała gra [1][2].

Ten przegląd jest zorganizowany jako **weryfikacja twierdzenie-po-twierdzeniu** ram czterech klastrów, gradując każdy element. Uzupełnia (nie powtarza) istniejący przegląd krajobrazowy projektu, który

pokrywa zaburzenia odżywiania, zbieractwo, agorafobię, unikanie
żądań i problem podwójnej empatii bardziej dogłębnie.

2. Klaster 1 — Rdzenne profile neurodywergencyjne

Autyzm (fundacyjny, najsilniejszy związek)

Monotropizm został *stworzony*, by wyjaśnić cechy autystyczne — intensywne specjalne zainteresowania, potrzeba rutyny (która chroni tunel uwagi) i różnice w interakcji społecznej [1]. MQ potwierdza to empirycznie: uczestnicy autystyczni osiągnęli średnio **4,15/5** vs **3,19/5** dla nie-autystycznych ($n=1.110$) [2]. To jest rodzinny grunt teorii i najlepiej ugruntowany związek.

ADHD (realny i mierzony)

ADHD znacznie podnosi wyniki monotropizmu ($\beta = +0,55$, $p < ,001$) [2]. Połączenie jest konceptualne tak samo jak statystyczne: **hyperfocus** ADHD (Grotewiel et al., 2022, o hyperfocus jako odrębnym konstrukcie) jest konceptualnie niemal identyczny z monotropowym tunelem, a „dyseksekutywna dysfunkcja” aktywacji uwagi dla nie-interesujących zadań to naturalna predykcja systemu tunelowanego [2][6]. **Poparte.**

AuDHD (twierdzenie wiodące jest odwrotne) — kluczowa korekta

Sprawdzone twierdzenie: „Ludzie z połączonym profilem AuDHD osiągają najwyższe wyniki MQ ze wszystkich grup.”

To nie jest to, co pokazują dane. Wielokrotna regresja pracy MQ zregresowała monotropizm na status ADHD, status autyzmu i ich **interakcję** [2]:

Predyktor (vs żadnego z warunków)	β	p
ADHD, nie autystyczny	+0,55	<,001
Autystyczny, nie ADHD	+1,04	<,001
Interakcja Autyzm $\times$ ADHD	-0,43	<,001

Czynnik interakcji jest **negatywny i znaczący**. Autorzy mówią to wprost: „wyniki monotropizmu nie są tak wysokie dla jednostek autystycznych z ADHD, jak można by oczekiwać na podstawie czysto addytywnych efektów” [2]. Innymi słowy, dodawanie ADHD do autyzmu **nie** pcha monotropizmu wyżej, niż sam autyzm przewidywałby — przychodzi **niżej** niż suma dwóch niezależnych efektów.

- **Najwyżej oceniająca pojedyncza grupa** to ludzie autystyczni (4,15); czy empiryczna *średnia komórki* dla autystyczni-z-ADHD siedzi powyżej czy poniżej tego zależy od dokładnej kombinacji, ale twierdzenie ramek, że AuDHD jest „*najwyższy ze wszystkich*” jako efekt addytywny/super-addywny jest **niepoparty i zaprzeczony przez interakcję**.
- *Intuicyjny obraz*, który oferują ramy — „wewnętrzny ciągnięcie między autystyczną potrzebą stabilnego, głębokiego tunelu a ADHD-owym napędem ku nowemu inputowi” — jest popularnym i fenomenologicznie rezonującym opisem doświadczenia AuDHD, ale to **narracja kliniczna/społecznościowa, nie wynik punktacji MQ**. Sformułuj to jako doświadczenie żywe, nie jako wynik MQ [6].

Skorygowane twierdzenie: „Zarówno autyzm, jak i ADHD niezależnie podnoszą wyniki monotropizmu, ale dwa interagują nie-addywnie: autystyczni ludzie z ADHD oceniają niżej na MQ, niż przewidywałby model czysto addytywny — sugerując, że dwa warunki nie po prostu „stosują się” na tendencji monotropowej.” [2]

3. Klaster 2 — Cechy kognitywne i zdrowia psychicznego

Lęk i ruminacja (robustna asocjacja, plauzybilny mechanizm)

Lęk i ruminacja są podwyższone w populacji autystycznej/ADHD, a ramy monotropizmu oferują czysty mechanizm: tunelowany umysł, który chwyt się zmartwienia, przetwarza je w pętli („ruminacja”), czyniąc lęk „lepki” [7][8]. Struktura 8-czynnikowa MQ zawiera nawet subskalę „**ruminacja i lęk**”, pokazując, że klaster jest empirycznie ciasny [2]. **Poparte** — choć zanotuj, że strzałka przyczynowa (czy monotropizm *produkuje* lęk, czy dzieli podłoże z nim?) nie jest ugruntowana.

OCD ✓ (robustne nakładanie, ważne rozróżnienie)

Nakładanie autyzm–OCD jest realne i replikowane. Metaanaliza znajduje, że około ~17% **ludzi autystycznych spełnia kryteria OCD** (vs ~1–2% w populacji ogólnej); odwrotnie też podwyższone [9]. Jakościowe rozróżnienie, które ciągną ramy, jest dokładnie trafne i dobrzeartykułowane: **monotropowe zainteresowania są ego-syntoniczne** (napędzane fascynacją/radością), podczas gdy **kompulsje OCD są ego-dystoniczne** (napędzane dystresem i wykonywane, by zneutralizować lęk) [10]. To rozróżnienie jest klinicznie ważne, bo dwa mogą inaczej być trudne do odróżnienia w praktyce. **Poparte.**

Hyper-systematyzacja ⚠ (realny konstrukt, ale to Baron-Cohena, nie wynik monotropizmu)

„Hyper-systematyzacja” — napęd analizowania, budowania i eksplorowania systemów — jest autentyczną i dobrzebadaną cechą autystyczną, ale należy do **teorii Empathizing–Systemizing (E-S)** Simona Baron-Cohena, nie do monotropizmu [5]. Dwie teorie silnie się nakładają (obie opisują intensywny, zorientowany na detal styl kognitywny) i czasem są mylone, ale są **odrębnymi ramami** z odrębnymi miarami (iloraz EQ/SQ vs MQ). Uczciwy ruch: przedstawiaj hyper-systematyzację jako *spójną* z stylem monotropowym (tunelowaty umysł jest dobrze przystosowany do opanowywania systemów), kredytując teorię E-S jako własną rzecz [1][5].

4. Klaster 3 — Zjawiska neurologiczne i przetwarzania

Problemy z trwałością obiektu ✗ (sporne — druga kluczowa korekta)

Sprawdzone twierdzenie: „Jednostki monotropowe doświadczają trwałości obiektu inaczej ... mózg efektywnie przestaje przetwarzać jego istnienie, dopóki coś egzogennie nie wyciągnie ich z powrotem.”

To jest **najsłabsze twierdzenie** w ramach i potrzebuje ostrożnego obchodzenia:

- Jest **jedno** akademickie źródło proponujące link trwałości obiektu: **Lawson & Dombroski (2017)**, które *hipotetyzuje*, że **opóźniona** trwałość obiektu może przyczyniać się do pewnego stresu i lęku

związanego z autyzmem [4]. Uwaga: to artykuł budowania-hipotezy, nie studium potwierdzenia.

- Szersza literatura rozwojowa znajduje, że podstawowa **trwałość obiektu jest typowo nienaruszona lub lepsza w autyzmie**; piagetowskie zadania trwałości obiektu są zwykle zdawane w typowym wieku [4].
- *Realne* zjawisko, do którego ramy sięgają — „poza wzrokiem, poza myślami” dla zadań, obiektów, a nawet ludzi — lepiej tłumaczy się jako efekt **pamięci operacyjnej / alokacji uwagi**: tunelowaty umysł nie *zawodzi* w reprezentowaniu przedmiotu, **zawodzi w reorientacji uwagi z powrotem do niego**. To jest monotropizm działający jak przewidziano (tunelowaty system ma mało wolnych zasobów na reorientację obwodową), nie deficyt trwałości obiektu [1][4].

Skorygowane twierdzenie: „Doświadczenie 'poza wzrokiem, poza myślami' u wysoce monotropowych ludzi lepiej rozumie się jako efekt alokacji uwagi / pamięci operacyjnej — umysł reprezentuje przedmiot, ale nie reorientuje się do niego, gdy jest tunelowany — raczej niż jako deficyt trwałości obiektu (która jest typowo nienaruszona w autyzmie).” [1][4]

Dysregulacja sensoryczna / przytłoczenie (dobrze poparty mechanizm)

To jest silnie poparte. Bo tunelowaty system wydaje swoje zasoby centralnie, nagły intruzyjny input sensoryczny (syrena, światło, dotyk) żąda kosztownej realokacji — doświadczane jako „gwałtowne zakłócenie”. To zbiega się z ugruntowaną literaturą nad-reaktywności sensorycznej i dobrze udokumentowaną drogą od przeciążenia sensorycznego do **meltdownu** (externalizujący) i **shutdownu** (internalizujące wycofanie), oba uznane jako nieświadome reakcje przytłoczenia [7][11]. Ramy monotropizmu dodają *mechanizm* (koszt realokacji) do tego, co inaczej jest deskryptywnym wynikiem. **Poparte.**

Autystyczna bezwładność (realna, coraz badana)

„Głęboka trudność z przejściami — problem z rozpoczęciem, zatrzymaniem lub zmianą kierunku” to ugruntowany konstrukt **autystycznej bezwładności**: trudność z

inicjacją/kończeniem/przełączaniem zadań „nie pod świadomą kontrolą”, po raz pierwszy sformułowana w narracjach społeczności autystycznej i teraz w pracach recenzowanych [12][13]. Jest konceptualnie *behawioralną* twarzą „kosztu przełączania”, który chwytu czynnik środowisko-i-tunel MQ [2]. **Poparte** — i jest poprawnym terminem technicznym (zob. przegląd towarzyszący o scoringu/bezwładności).

5. Klaster 4 — Wyniki przewlekłego stresu

Monotropic split ⚠ (poprawnie przypisane Adkin, ale dwa znaczenia są pomieszane)

Sprawdzone twierdzenie: „*Monotropic split, ukuty przez praktyk Tanya Adkin, występuje, gdy monotropowy umysł jest zmuszony przez swoje środowisko do rozdzielenia swojego pojedynczego fokus kanału na wiele konkurujących strumieni.*”

Przypisanie jest poprawne: autystyczna adwokat **Tanya Adkin** rzeczywiście ukuła „monotropic split”, potwierdzone przez wiele niezależnych źródeł społeczności [3]. I definicja ramek tutaj jest **bliska rzeczywistemu znaczeniu Adkin** — kognitywny koszt/burnout, który wynika, gdy monotropowy umysł jest *zmuszony do „perform polytropowo”* lub podzielić swoją uwagę na konkurujące strumienie [3] [14].

Dwa zastrzeżenia:

1. **To konstrukt społecznościowy/praktyka, nie empirycznie zwalidowany konstrukt.** „Monotropic split” pojawia się w piśmiennictwie społeczności-autystycznej i klinicznym (np. przez Neurodivergent Insights, Kelly Mahler, David Gray Hammond) ale **nie ma recenzowanego studium walidacyjnego** za nim [3]. Traktuj to jako potężny, z-doświadczenia-ważny *opis*, nie mierzoną jednostkę.
2. **Dwie różne rzeczy podróżują pod nazwą.** Sens Adkin = *wymuszone polytropowe performans przez monotropowy umysł* (problem dopasowania środowiskowego). Drugi sens — używany w pewnym piśmie AuDHD — = *wewnętrzna konkurencja między autystyczną potrzebą stabilnego tunelu a ADHD-owym napędem nowości* (problem wewnętrznej dynamiki). Ramy tutaj opisują **pierwszy** (środowiskowy)

sens. Są powiązane, ale odrębne; zapadanie ich mętni konstrukt. (Przegląd krajobrazowy projektu używa „monotropic split” w drugim sensie AuDHD — więc termin jest genuinely przeładowany w dziedzinie.) [3][6]

Sformułuj to jako: „Termin 'monotropic split' autystycznej adwokat Tanya Adkin opisuje kognitywny koszt i burnout, które wynikają, gdy monotropowy umysł jest zmuszony do operowania polytropowo — potężny konstrukt społecznościowy, który czeka na formalną walidację.” [3]

Burnout (ugruntowany konstrukt; link monotropizmu jest heurystyczny)

Autystyczny burnout jest teraz dobrze zdefiniowanym konstruktem: **przewlekłe wyczerpanie, utrata umiejętności i zmniejszona tolerancja na bodziec**, konceptualizowane jako wynik przewlekłego stresu życiowego i „niedopasowania oczekiwań i zdolności” bez odpowiedniego wsparcia i regeneracji (Raymaker et al., 2020; Higgins et al., 2021, studium Grounded-Delphi z autystycznymi ekspertami) [15] [16]. Ścieżka monotropizmu w burnout — ciągle wymuszone przejścia, maskowanie i „monotropic split” odprowadzający zasoby bez czasu regeneracji/flow — jest **heurystycznie potężna i społecznie zwalidowana**, ale *specyficzny* wkład pęknięcia tunelu w burnout (vs maskowanie, trauma, obciążenie sensoryczne, przewlekłe żądanie) **nie został wyizolowany eksperymentalnie** [15]. **Poparte jako silna hipoteza, nie ugruntowany łańcuch przyczynowy.**

6. Gradowana karta wyników

Twierdzenie w ramach	Werdykt	Uwaga
Monotropizm nie ma komorbidności-choroba	 Poprawne	Ma asocjacje + współdzielone mechanizmy [1]
Autyzm = związek główny	 Fundacyjny	MQ 4,15 vs 3,19 [2]
ADHD podnosi monotropizm	 Poparte	$\beta = +0,55$ [2]

Twierdzenie w ramach	Werdykt	Uwaga
AuDHD ocenia najwyżej ze wszystkich	✗ Odwrócone	Interakcja jest negatywna ($\beta=-0,43$) [2]
Nakładanie lęk i ruminacja	✓ Robustne	MQ ma czynnik ruminacja/lęk [2]
Nakładanie OCD (ego-syntoniczne vs dystoniczne)	✓ Poparte	~17% ko-występowania; rozróżnienie poprawne [9] [10]
Hyper-systematyzacja	⚠ Realna, ale błędnie etykietowana	To teoria E-S Baron-Cohena, nie monotropizm [5]
Problemy z trwałością obiektu	✗ Sporne	1 artykuł hipotezy; TO zwykle nienaruszona; to alokacja uwagi [4]
Przytłoczenie sensoryczne → meltdown/shutdown	✓ Dobrze poparte	Mechanizm = koszt realokacji [7][11]
Autystyczna bezwładność	✓ Realna	Poprawny termin; recenzowane [12][13]
Monotropie split ukuty przez Adkin	⚠ Przypisanie poprawne; społecznościowe, nie zwalidowane	Dwa znaczenia pomieszane [3]
Burnout z wymuszonych przejść + maskowania	✓ Ugruntowany konstrukt; link heurystyczny	Nie wyizolowane eksperymentalnie [15][16]

7. Praktyczne wnioski

- **Otwórz z zasadą:** monotropizm to mierzalny styl uwagi, którego *nakładania* z warunkami to asocjacje i współdzielone mechanizmy — nigdy „powoduje X.” [1]
- **Cytuj MQ poprawnie:** autyzm i ADHD każdy podnoszą wyniki, ale kombinacja jest **nie-adtywna (niższa niż oczekiwana)** — nie mów, że AuDHD ocenia najwyżej [2].
- **Utrzymuj rozróżnienie ego-syntoniczne/ego-dystoniczne** omawiając OCD vs specjalne zainteresowania — jest klinicznie użyteczne i poprawnie sformułowane [10].

- **Kredytuj ramy precyzyjnie:** hyper-systematyzacja = teoria E-S Baron-Cohana; monotropic split = konstrukt społecznościowy Adkin (środowiskowy sens wymuszonej polytropii); autystyczna bezwładność = recenzowany konstrukt trudności przejść [3][5][12].
- **Odpuść „deficyt trwałości obiektu”:** reframuj jako alokacja uwagi / pamięć operacyjna, co jest i dokładne, i bardziej użyteczne dla wsparcia [1][4].
- **Rozróżniaj zwalidowane vs heurystyczne:** burnout to ugruntowany konstrukt, ale ścieżka monotropizm→burnout to silna hipoteza, nie mierzony efekt; „monotropic split” jest z-doświadczenia-ważny, ale niezweryfikowany [3][15].

Źródła

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. *Autism*, 9(2), 139–156.

doi:10.1177/1362361305051398 — początek monotropizmu; różnica w alokacji zasobów (kontinuum), nie deficyt.

<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

[2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (self-report 47-item; preprint walidacyjny). Open Science Framework. — n=1.110; średnia autystycznych 4,15 (OD ,347) vs nie-autystycznych 3,19 (OD ,578); regresja $\beta(\text{ADHD})=+0,55$, $\beta(\text{autyzm})=+1,04$,

$\beta(\text{interakcja})=-0,43$, $p<,001$; interakcja ADHD+autyzm jest *sub-adywna*; struktura 8-czynnikowa włącz. czynniki ruminacja/lęk i środowisko/tunel. <https://osf.io/wpx5g> · walidacja: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Lokalne archiwum: [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)

[3] Adkin, T. — „monotropic split” (autystyczna adwokat / praktyk; konstrukt społecznościowy). Potwierdzone przez wiele niezależnych źródeł społeczności: Neurodivergent Insights (glosariusz), Kelly Mahler (post gościnny), David Gray Hammond, Jade Farrington („Kiedy monotropowi ludzie są zmuszeni operować polytropowo, jest to znane jako monotropic split”). Definicja: kognitywny koszt/burnout zmuszania monotropowego umysłu do „perform polytropowo”. Konstrukt społecznościowy/praktyka — **brak recenzowanego studium**

walidacyjnego. <https://jade-farrington.medium.com/what-is-monotropic-split-1c7c46fd9017> · <https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/interoception-and-monotropism>

[4] Lawson, W. & Dombroski, B. (2017). *Problems with Object Permanence: Rethinking Traditional Beliefs Associated with Poor Theory of Mind in Autism*. J. Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 5(1).

doi:10.6000/2292-2598.2017.05.01.1 — *hipotetyzuje opóźnioną* trwałość obiektu jako współpracownika pewnego stresu związanego z autyzmem (artykuł budowania-hipotezy, nie potwierdzenie). Szersza literatura: trwałość obiektu jest typowo nienaruszona/lepsza w autyzmie; „poza wzrokiem, poza myślami” lepiej czyta się jako alokacja uwagi/pamięć operacyjna. Lokalne archiwum: [sources/12-object-permanence-lawson-dombroski.pdf](#) ·

<https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/4562>

[5] Baron-Cohen, S. (2009/2010). *Autism and the empathizing–systemizing (E-S) theory; the hyper-systemizing theory of autism*. Annals of the NYAS; APA PsycNet. — hyper-systematyzacja i teoria E-S są ramami Baron-Cohana, mierzone przez iloraz EQ/SQ; odrębne od (choć nakładające się z) monotropizmu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Empathising%E2%80%93systemising_theory · przegląd: Greenberg & Baron-Cohen, *Empathizing-Systemizing Theory: Past, Present, and Future*.

[6] Autistic Scholar — „*Revisiting monotropism*” (AuDHD jako konkurujące/niestabilne tunele; referencje Grotewiel et al. 2022 o ADHD hyperfocus jako odrębnym konstrukcie). Konto

fenomenologiczne/społecznościowe, nie wynik punktacji MQ. Lokalne archiwum: [sources/13-revisiting-monotropism-autisticscholar.html](#)

· <https://www.autisticscholar.com/monotropism>

[7] Green, S. A. & Ben-Sasson, A. (2010). *Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship?* J. Autism and Developmental Disorders. PMC2980623 — nad-reaktywność sensoryczna, warunkowanie kontekstu i droga przytłoczenia.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623>

[8] Oakley, B. et al. / literatura lęku w autyzmie — podwyższony lęk i ruminacja w populacji autystycznej/ADHD (zacytowane przez przegląd krajobrazowy komorbidności projektu dla podłoża lęku).

[9] Meier, S. M. et al. / metaanalizy konkordancji autyzm–OCD — ~17% ludzi autystycznych spełnia kryteria OCD (vs ~1–2% populacja ogólna); ~17% dzieci z OCD pokazuje łagodne objawy autystyczne. Podsumowane via Move Up ABA cytując badania 2015 i przegląd The Transmitter/Spectrum.

<https://www.thetransmitter.org/spectrum/sweeping-study-underscores-autisms-overlap-with-obsessions> · metaanaliza autyzm↔OCD:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11048346>

[10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). *"Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours* (jakościowo). PMC11497754 — rozróżnienie ego-syntoniczne (zainteresowania) vs ego-dystoniczne (kompulsje). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754>

[11] Autism Society (2025). *Autistic Meltdowns and Shutdowns* — meltdown (externalizujący) i shutdown (internalizujące wycofanie) jako nieświadome reakcje na przytłaczający stres/input sensoryczny.

https://autismsociety.org/wp-content/uploads/2025/07/AutismSociety_Autistic-Meltdowns-Shutdowns_2025-06V2F_Digital.pdf

[12] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia* (preprint/jakościowo). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — trudność rozpoczynania, zatrzymywania i przełączania zadań „nie pod świadomą kontrolą”. Lokalne archiwum: [sources/11-autistic-inertia-osf.pdf](#) · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x>

[13] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer — autystyczna bezwładność: społecznościowo-pochodna, teraz recenzowana; cytuje Carls-Diamante & Laciny 2024, Greaves-Lord et al. 2023, Buckle 2021, Heasman 2024, Rapaport 2024. <https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>

[14] Neurodivergent Insights — *Monotropism* (glosariusz) i *ADHD vs Autism vs OCD* (trójstronne nakładanie). Zasób społecznościowy/kliniczny rama monotropic split i nakładania. <https://neurodivergentinsights.com/glossary/monotropism> · <https://neurodivergentinsights.com/adhd-vs-autism-vs-ocd>

[15] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143.

doi:10.1089/aut.2019.0079 — przewlekłe wyczerpanie, utrata umiejętności, zmniejszona tolerancja na bodziec; z przewlekłego stresu i niedopasowania oczekiwań i zdolności.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> ·

https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378

[16] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating*

#AutisticBurnout. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 —

definicja konsensusu: wyczerpanie, wycofanie, problemy kognicji,

zmniejszone umiejętności życia codziennego, zwiększone cechy

autystyczne. [https://www.autismcrc.com.au/knowledge-](https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic)

[centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic](https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic)

Uzupełnia pełniejszy przegląd krajobrazowy projektu:

[outputs/monotropism-comorbidity-landscape.md](#) (który pokrywa zaburzenia odżywiania, zbieractwo, agorafobię, unikanie żądań/PDA i problem podwójnej empatii). Ten przegląd skupia się na weryfikacji ram czterech klastrów powyżej i nie powtarza tego materiału.